Síndromes pulmonares

SEMIOLOGIA · Clase 17 · condensación, atelectasia, enfisema y embolia

1 · LO QUE HAY EN EL ALVÉOLO DECIDE EL HALLAZGO

Diagnóstico sindrómico
ningún dato aislado define el síndrome: lo separa la combinación de palpación, percusión y auscultación

la palpación separa la

Vibraciones aumentadas + matidez F1
solo en la condensación: el pulmón sólido con bronquio abierto transmite mejor la voz

en cambio en los otros

En atelectasia y derrame las vibraciones están disminuidas o abolidas; el enfisema no da matidez

la radiografía separa la

Clave radiológica
la atelectasia jala el mediastino al lado enfermo; el derrame voluminoso lo empuja al lado sano

si aún hay duda se hace la

Ante la duda radiológica: punción pleural exploradora

2 · CONDENSACIÓN: EXUDADO CON EL BRONQUIO ABIERTO

Germen más frecuente F6
neumococo, luego Haemophilus influenzae

llega sobre todo por

Vía principal
microaspiración de secreciones orofaríngeas (también [illegible]ación, hematógena y por continuidad)

si el alvéolo se llena de exudado

siembra el alvéolo:

Síndrome de condensación F4
el exudado reemplaza el aire del alvéolo y el bronquio sigue abierto

si ocupa un solo lóbulo es

Neumonía lobar F5
un solo foco que ocupa un lóbulo y toca la pleura; muchos focos dispersos serían bronconeumonía

puede complicarse con

Complicaciones
derrame paraneumónico, absceso, empiema o sepsis

se manifiesta con

Clínica
fiebre, tos mucopurulenta, disnea y dolor pleurítico localizado

por pérdida de volumen es la

se explora y, si el foco

Para dar el patrón completo
foco pleural de más de 6 cm que llega a bronquios de 3 mm

entonces da su

Firma exploratoria F2 · F3
expansibilidad disminuida, VV aumentadas, matidez, MV abolido con crepitantes, soplo tubárico y pectoriloquia

su frémito aumentado es la

se confirma en la

Radiografía
opacidad con broncograma aéreo: los bronquios con aire se ven oscuros dentro del pulmón opaco

la más grave es la

3 · ATELECTASIA: BRONQUIO TAPADO Y ALVÉOLO COLAPSADO

Obstrucción bronquial
el bronquio se tapa desde dentro o desde fuera

desde la luz

Intrínseca
secreción espesa, cuerpo extraño o tumor

desde fuera

Extrínseca
ganglio comprimido, tuberculoso o neoplásico (afecta bases y lóbulo medio)

tapa el bronquio y colapsa:

comprime el bronquio y colapsa:

si el bronquio se tapa

Atelectasia
desaparece el aire del alvéolo y el lóbulo se colapsa

puede complicarse con

Complicaciones
supuración pulmonar, derrame, empiema o insuficiencia respiratoria

al explorar da su

Firma exploratoria F7 · F8
retracción intercostal, VV abolidas, matidez o submatidez, MV disminuido o abolido

si la membrana se engruesa

se confirma en la

Radiografía
opacidad que atrae el mediastino y la tráquea al lado enfermo

4 · ENFISEMA: PAREDES ROTAS Y AIRE ATRAPADO

Causa principal F9
tabaquismo, luego el polvo atmosférico

destruye la pared alveolar:

si las paredes se destruyen

Enfisema
dilatación irreversible de alvéolos con destrucción de las paredes: el aire queda atrapado

en fases tardías da

Fases tardías
disnea de reposo, cianosis y acropaquia

al explorar da su

Firma exploratoria F10
tórax en tonel, VV disminuidas, percusión normal o hipersonora, espiración prolongada, roncus y sibilancias

se confirma en la

Radiografía
hiperclaridad, diafragma aplanado y corazón alargado y estrecho

termina en la

6 · MEMBRANA ENGROSADA Y EDEMA DE ALTURA (🛍)

Membrana engrosada (🛍)
fibrosis intersticial, neumoconiosis, sarcoidosis, edema intersticial

engruesan la membrana y causan el

Bloqueo alveolocapilar (🛍) F13
hay aire y hay sangre, pero el oxígeno no difunde

por la mala difusión produce

Hipoxemia por mala difusión, aunque el pulmón esté ventilado y perfundido

Ascenso a la altura (🛍)
la hipoxia contrae las arterias pulmonares, pero no por igual

contrae las arterias y causa el

Edema pulmonar de altura (🛍) F14
vasoconstricción hipóxica desigual: los capilares sobreperfundidos se estresan

los capilares filtran y llevan al

Líquido en el alvéolo; el daño capilar es solo la consecuencia final

la más grave es la

5 · EMBOLIA PULMONAR: FALLA LA SANGRE, NO EL AIRE (🛍)

Trombosis venosa profunda (🛍) F11
el trombo de la pierna se suelta; sospecharla en el obeso o tras un viaje largo

al soltarse el trombo causa la

Embolia pulmonar (🛍) F11
el trombo tapa una rama de la arteria pulmonar: pulmón con aire pero sin sangre

si es masiva produce el

se manifiesta con

Cuadro súbito F11
disnea aguda, taquicardia, dolor pleurítico y hemoptisis

si infarta el pulmón causa el

Infarto pulmonar
irrita la pleura: dolor pleurítico y hemoptisis

Cor pulmonale agudo
si la embolia es masiva, el ventrículo derecho claudica de golpe

por el pulmón sin sangre da

Taquipnea F12
respira más rápido porque ventila un pulmón que no oxigena; una frecuencia baja es lo incorrecto

si se instala de golpe es el

7 · DE LA HIPOXIA SOSTENIDA AL COR PULMONALE

Síndromes crónicos de base
enfisema, bronquitis crónica, fibrosis, EPOC

mantienen la

es el que más lleva a la

Hipoxia sostenida
la ventilación se mantiene reducida

si falla el intercambio causa la

provoca la

Vasoconstricción de la arteria pulmonar
provocada por la hipoxia

Insuficiencia respiratoria
fallo del intercambio gaseoso que corona los síndromes crónicos

mantenida produce la

Hipertensión pulmonar
la vasoconstricción mantenida eleva la presión; a veces asintomática en jóvenes

se sospecha y se confirma con la

Se confirma con la gasometría arterial; se sospecha por cianosis y aleteo nasal

sostenida sobrecarga el VD y causa el

Cor pulmonale crónico
hipertrofia del ventrículo derecho, con o sin insuficiencia cardiaca derecha

si la arteria se tapa

concepto · diagnóstico · desenlace · causa · síndrome · ejemplo · síntoma · signo · complicación · mecanismo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología Médica — 07e Síndromes pulmonares y pleurales, 07a SÍntomas respiratorios, 05g Edema — teoría del docente (🛍 = literatura: embolia, bloqueo alveolocapilar, edema de altura)